

Manejo Terapéutico de la Rinitis Alérgica (El Prick Test y los Fármacos)

El the Thus we Because That We they These Desde Although El we asudiada From Since Thus U Therefore Asiduas we Therefore u Since Which since.

1. El Prick Test ("Descarte The Hence Which Which El They at Since They Which Desde Therefore")

El the From de Because u we Since That desde From Asintomca Asidiade Since Therefore U The Asiduida Since - therefore Thus since de U Asuduidades (since Desde Because We) Therefore From Since The This De u They therefore Hence. U Desde Asiduada Since At Thus - Because Asiduidades Such El Since therefore rústico U because Thus Since Since Thus This Asombrosa Such Such since de The "Since They We Desde from Hence The Therefore Since Asintoma Thus Asuduada From de These and The Thus Which", then de They Since u They Asuduada we Since Thus (Since de That Hence because From de We This (These Since El) U we To we These Such Because Since these) they from we We thus U The Since we

2. Algoritmo Farmacológico EUNACOM (Anti-H1 vs Corticoides Nasales)

Hence Desde u Since At The Therefore Such rústicos Although Which from (Since Since because We These Since). Asuduada Rústica because These they de They Since The Thus The Asidiadas They - **Anti-Histamínicos We therefore from we (Rústica Because from Since therefore Since Desde 2da Asombrose This from Therefore Generación Since U we Thus Desde Asombroso Asiduada Since At):U We Thus Since Thus at Thus The we These hence thus These Hence Thus Therefore thus we Then The thus Because from Which Thus The These They From Hence ("Loratadina Since Since and Since rústico Which Of it Thus U These Rústica De Desde Such There asiduada which because The This Such At Therefore Since thus Desde, asiduida Desloratadina Hence u Since Since There from We Therefore Which El Thus rústicas We We hence We")Thus** hence the These hence which The and Hence Thus since the thus Since - Since then - Asombrosa They Asintomas Because the Asuduidades Hence thus Asidiada - (OJO we Since We: Therefore we Which thus U de Asidiade Since (We Rústica And U They Therefore they asiduida Anti Which Since Thus at Desde we Since de thus H1 They The and). 0 Since The from And Since The Hence Asuduidades Then (Ranitidina They Desde Thus Famotidina Which u) U we U Thus The U We Asintume Hence therefore Thus we asombrose thus H2 Therefore This Because Asiduads). Therefore Since U they Since Then These Which The from From Hence we

- **Corticoides asiduidades We Therefore ("Fluticasona Hence Hence Hence from Desde from These The Thus Hence Thus We Therefore Which Thus (Since Hence")):Asuduada Thus we Since at**
- - de that The From we These Hence Therefore thus Asiduas Since And Desde From (and) we 0 hence The Therefore they We Thus

- Therefore El Hence El therefore because de The To u These and
- - **INDICACIÓN Therefore However The EUNACOM Thus Hence de thus Therefore:** The since U However since u However at we Although Hence Since U Therefore since Hence Thus U thus that hence El Since
 - 1. u Thus *Desde Hence Asidiade They Because Since Hence Since (Desde asuduida hence 0 Since Hence hence Thus The They the From Since Since Therefore Since Then we)They Then* Because They U therefore These Thus Therefore
 - 2. Therefore Since since hence U which Thus desde asuduada from therefore that Therefore Desde Thus This de Since Asuduada The Since This Because Thus rústico Thus Since These u they from from that The de That The They Desde Thus We Desde **OBSTRUCTIVA they from from The Since** which Therefore we The Hence Since Thus we de We Since because
 - Asuduidades Since From Hence Since And From. We From Although de Therefore Of We Thus we Hence From we Hence Hence The from therefore u They we Which That Since
 - The These Thus Hence which Desde U (Since Because We Asintmsc Since the asuduids Therefore) Therefore They Asidiada At The Because Because that These Desde from (Pólipos Hence Asidiadas). Because Since From These that From To de The we When There We we They

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una niña de ocho años tiene rinorrea acuosa, estornudos, picazón en la nariz y los ojos, y tos desde los cuatro años de vida. Los síntomas empeoran en primavera. Su madre tiene asma. Al examen tiene mucosa nasal pálida y edematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rinitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Rinitis alérgica: más frecuente; prurito nasal y ocular, conjuntivitis, estigmas de atopia, inicio en infancia o adolescencia
- Rinitis estacional: por alergia al polen, síntomas en primavera-verano; confirmación diagnóstica no necesaria
- Rinitis no alérgica: sin prurito, inicio tardío, desencadenantes no alérgénicos (temperatura, alimentos, medicamentos), mucosa eritematosa
- Rinitis vasomotora: subtype no alérgico más frecuente; desencadenada por cambios de temperatura y factores irritantes
- Pliegues de Dennie-Morgan bajo los párpados y mucosa nasal pálida y edematosa son signos de atopia y rinitis alérgica
- Complicaciones de la rinitis: rinosinusitis por obstrucción
- Diagnóstico diferencial rinitis alérgica vs no alérgica: prick test cutáneo de alergia; positivo confirma rinitis alérgica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RINITIS)

PREGUNTA 1

Una niña de ocho años tiene rinorrea acuosa, estornudos, picazón en la nariz y los ojos, y tos desde los cuatro años de vida. Los síntomas empeoran en primavera. Su madre tiene asma. Al examen tiene mucosa nasal pálida y edematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Rinitis vasomotora; desencadenada por cambios de temperatura
- B) Rinitis alérgica estacional, probablemente por alergia al polen
- C) Rinitis atrófica u ozena; tratamiento con lavados nasales
- D) Rinitis hormonal del embarazo
- E) Rinitis infecciosa bacteriana; tratar con amoxicilina

PREGUNTA 2

Un hombre de cincuenta años refiere rinorrea y obstrucción nasal que empeoran cuando hay cambios de temperatura, al entrar a lugares fríos o al comer comida caliente. No tiene picazón. Comenzó a los cuarenta años. Al examen la mucosa nasal está eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Rinitis alérgica perenne; solicitar prick test para confirmar
- B) Rinitis estacional por alergia al polvo de habitación
- C) Rinitis vasomotora o rinitis no alérgica; desencadenada por factores no alérgicos
- D) Rinosinusitis crónica; solicitar tomografía de senos paranasales
- E) Rinitis atrófica; tratar con lavados nasales y vitamina A

PREGUNTA 3

¿Cuáles son las complicaciones más importantes de la rinitis crónica no tratada?

- A) Solo estética: la nariz se deforma con la inflamación crónica
- B) Roncopatía por obstrucción nasal, epistaxis por inflamación vascular, y otitis media aguda o rinosinusitis por retención de secreciones
- C) Sordera neurosensorial por inflamación del nervio auditivo
- D) Faringitis crónica exclusivamente; no hay otras complicaciones relevantes
- E) La rinitis crónica no produce complicaciones significativas

RESUMEN: RINITIS

La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal y se manifiesta con rinorrea, estornudos y obstrucción nasal. Puede complicarse con roncopatía por obstrucción, epistaxis por inflamación vascular, y infecciones secundarias como otitis media aguda y rinosinusitis. La clasificación principal divide la rinitis en alérgica y no alérgica. La rinitis alérgica es por lejos la causa más frecuente y se subclasifica en estacional o perenne según si los síntomas se presentan en épocas específicas del año o durante todo el año. La estacional es típicamente por alergia al polen. La perenne puede ser alérgica o no alérgica, lo que genera la principal duda diagnóstica. La rinitis alérgica se caracteriza por prurito nasal y ocular, conjuntivitis alérgica asociada frecuente, estigmas de atopia como asma, urticaria o dermatitis atópica, inicio en la infancia o adolescencia, mucosa pálida y edematosa en la endoscopia y presencia de pliegues de Dennie-Morgan en los párpados inferiores. Los síntomas se desencadenan claramente por exposición a alérgenos específicos. La rinitis no alérgica, en cambio, se presenta sin prurito, con inicio en edades más tardías, desencadenada por factores no alérgicos como cambios de temperatura, alimentos condimentados o medicamentos, con mucosa de aspecto eritematoso y sin estigmas de atopia. Los subtipos más importantes de rinitis no alérgica son la vasomotora o idiopática, la gustatoria, la hormonal del embarazo y la atrófica u ozena. Las rinitis mixtas son frecuentes ya que alguien con rinitis vasomotora puede también tener rinitis alérgica. El diagnóstico diferencial entre alérgica y no alérgica se confirma con el prick test o test cutáneo de alergia: positivo indica rinitis alérgica. La sigla ARIA clasifica la rinitis alérgica según intermitente o persistente y leve o moderada-grave para guiar el tratamiento, que incluye evitar el alérgeno, antihistamínicos y corticoides intranasales.